Boca, lengua, nariz y cuello

SEMIOLOGIA · Clase 08 · con buena luz, la boca, la nariz y el cuello delatan infecciones, carencias y meningitis

1 · LA BOCA: LUZ, BAJALENGUAS Y MUCOSA

Examen de la boca
con buena luz y bajalenguas, retirando las prótesis; mucosa normal rosada y homogénea

en la mejilla frente a los molares

Manchas de Koplik F1
puntos blancos con halo rojo en la mucosa de la mejilla, frente a los molares

por eso permiten diagnosticar

Sarampión F1
se ven antes del exantema: permiten aislar al niño a tiempo

si no abre la boca hay

Trismus F2
contractura del masetero: el paciente no puede abrir la boca

es típico del

Tétanos o fenotiazinas F2

impide examinar la

al fondo explora con el

Faringe con bajalenguas
presionar el lado de la lengua y pedir «A»; ni la punta (obstruye la vista) ni la base (náusea)

si se ve roja o supurada

Faringitis o amigdalitis
faringe roja; amígdalas crecidas y supuradas

se completa con el

si no tiene olor concreto hay

después examina la

después se examina la

2 · EL ALIENTO

Aliento con olor característico
alcohólico, urémico, hepático o cetónico (a manzana)

si huele a algo concreto

Causa sistémica
el cetónico orienta a cetoacidosis diabética

Halitosis F3
mal olor del aliento sin olor característico

lo más común son causas

Causas locales (las más frecuentes) F3
mal aseo, restos de comida, caries, infecciones bucales, prótesis, tabaco

también puede venir de causas

Causas respiratorias y digestivas F3
rinitis, sinusitis, bronquiectasias; dispepsia, obstrucción intestinal, insuficiencia hepática, Zenker

3 · LA LENGUA: TRES POSICIONES Y SUS TIPOS

Examen de la lengua
tres posiciones: en reposo, afuera y con la punta tocando el paladar

si tiene papilas gruesas

En fresa F4
papilas gruesas y rojas

orienta a

Escarlatina F4
estreptococo betahemolítico grupo A

si tiene surcos

Escrotal F4
surcos irregulares, como la piel del escroto

orienta a

Déficit de vitamina B F4
vigílala: puede coexistir con leucoplasia

si está seca

De loro F4
seca, sin humedad

orienta a

Deshidratación F4

antes de concluir descarta

No confundir
respirar por la boca (postoperatorio) reseca la lengua sin deshidratación

si tiene natas blancas

Blanca (algodoncillo)
colonias de Cándida con defensas bajas

si está roja y duele

Glositis F5
lengua roja, inflamada y dolorosa con alimentos calientes o salados

se puede acompañar de

Temblor lingual F5
se acompaña a la glositis en el cuadro del docente

orienta a

Hipertiroidismo, alcoholismo o Parkinson F5
el banco responde corea, que no figura en la teoría

si duele pero se ve normal

Glosodinia F6
la lengua arde o duele pero se ve normal (boca ardiente)

sin lesión visible, por

Dolor sin lesión visible F6
mujeres posmenopáusicas, anemias, déficit de B12 o hierro, xerostomía, ansiedad o depresión (literatura 📚)

4 · LA NARIZ: OLFATO, SENOS Y PERMEABILIDAD

Examen de la nariz
síntomas, forma y permeabilidad: tapar un orificio y luego el otro

si cambia el olfato

Alteraciones de la calidad del olfato F8
parosmia y cacosmia (también hiposmia y anosmia)

si el olor se interpreta mal

Parosmia F8
el olor se interpreta mal

por alteración

Origen neurológico F8
vía olfatoria del techo de la nariz

si se huele algo feo

Cacosmia F8
se huele algo feo, subjetivo u objetivo

por pus en los senos:

Sinusitis purulenta crónica F8
pus en los senos

se completa con la

Presión sobre los pómulos
la busca el dolor de la sinusitis

si duele

Sinusitis
pómulos dolorosos y secreción purulenta verde-amarillenta

si hay secreción serosa y estornudos

Rinitis alérgica
secreción serosa y estornudos

el síntoma más importante es la

por último se examina el

5 · EPISTAXIS: DE DÓNDE Y POR QUÉ SANGRA

Epistaxis
la hemorragia más frecuente de todas

con más frecuencia nace en el

Área de Kiesselbach F7
parte anterior y baja del tabique: varias arterias bajo una mucosa fina que se reseca y se rasca (literatura 📚)

por eso es el

Sitio más frecuente de origen F7

por lesión en la nariz

Causas locales
traumatismo, fractura nasal o de base de cráneo, rinitis, sinusitis, tumores, cocaína

si recurre sin causa local

por enfermedad general

Causas sistémicas
fiebre, tos violenta, hipertensión, cirrosis, hemofilia, leucemia, púrpura

si recurre sin causa local

Conducta
si recurre sin causa local, pedir coagulación y revisar la presión arterial

6 · EL CUELLO: RIGIDEZ DE NUCA Y SIGNOS MENÍNGEOS

Examen del cuello
inspección, palpación y auscultación; no se percute

para meninges se busca la

Rigidez de nuca F9
cama plana, una mano bajo el occipital: se flexiona la cabeza hacia el pecho

si hay resistencia

Resistencia dolorosa a la flexión F9
las meninges inflamadas duelen al estirarse

orienta a

a diferencia de la tortícolis

el tercer signo es el

Brudzinski
al flexionar el cuello, el paciente flexiona caderas y rodillas

si es positivo

el segundo signo es el

Kernig
con la cadera a 90°, no se deja extender la rodilla

si es positivo

Meningitis F9
viral o bacteriana; el TEC solo si hay hemorragia subaracnoidea (literatura 📚)

si se contrae un músculo hay

Tortícolis
contractura del esternocleidomastoideo: desvía el cuello

no confundir con rigidez

No confundir
la tortícolis desvía el cuello; la rigidez de nuca no se deja flexionar

---

- ▭ técnica
- ▭ signo
- ■ desenlace
- ⬚ ejemplo
- ⬭ síntoma
- ▭ mecanismo
- ▭ causa
- ▭ borde dorado = alto rendimiento
- F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor 2020 y 2018 · 06b Oídos, nariz y cavidad oral; 06c Cuello; 11e signos meníngeos — teoría del docente (📚 = literatura)